

BRIEVEN AAN DE REDACTIE

(De redactie behoudt zich het recht voor de stukken in te korten)

Diagnostische aanpak bij patiënten met vermoeden op acute appendicitis

W.J. Kwanten, P.A. Pelckmans, W. Vaneerdeweg,
J. Denekens, T.G. Moreels

Tijdschr Geneesk 2011; 67: 1045-1050

Geachte redactie,

In bovenvermelde tekst wordt ons het nuttige Alvarado-scorings-systeem aangereikt om de diagnose van acute appendicitis met meer zekerheid te kunnen stellen (1). Omdat er ook na de toepassing van deze sleutel een belangrijke grijze zone blijft bestaan waarbij de kans op appendicitis reëel blijft, raden de auteurs terecht echografie aan als voorkeursoronderzoek bij kinderen en zwangere vrouwen en dit om de gevaarlijke effecten van stralenbelasting door een CT-scan zoveel mogelijk te beperken.

– migratie van de pijn	1
– anorexia	1
– nausea/braken	1
– pijn bij hoest/percussie/springen	2
– rechterfossa pijn	2
– koorts (> 38°C oraal of rectaal)	1
– leukocytose > 10.000/microl	1
– polymorfonucleaire neutrofielen > 7.500/microl (75%)	1
PAS-scores bij vermoeden appendicitis	
PAS-score ≤ 4 NVW	= 97,7%
PAS-score ≥ 8 PVW	= 85,2%

Een ander scoresysteem dat door de auteurs niet werd vermeld en vooral bij kinderen gebruikt wordt, is de PAS-score (Pediatrische Appendicitis Score). Deze „PAS-score”, die net zoals de Alvarado-score eveneens prospectief gevalideerd werd (2), werd ook voorgesteld tijdens avondcolloquia voor huisartsen te Gent (3). Hij maakt gebruik van een variant van de bestaande scoringsleutels. In deze PAS-studie, uitgevoerd op een pediatrische spoedgevallendienst, had uiteindelijk 34% (n = 83) anatomisch-pathologisch bewezen appendicitis. Voor de praktijk werden twee afkappunten voorgesteld. Kinderen met een PAS-score ≤ 4 konden ontslagen worden uit het ziekenhuis zonder verder onderzoek, bij deze groep

was de negatief voorspellende waarde (NVW) immers 97,7%. Bij een score ≥ 8 was de positief voorspellende waarde (PVW) echter 85,2%, deze groep kon zonder verder onderzoek meteen een laparoscopie ondergaan.

Bij de groep met een score van 5, 6 of 7 is verdere beeldvorming aangewezen. Met gebruik van de PAS-score kon in deze studie uiteindelijk een percentage van 41% aan stralenbelastende CT-scans vermeden worden (2). Hoewel PAS en Alvarado (de laatste score werd oorspronkelijk ontworpen voor volwassenen en later aangepast voor kinderen) te vergelijken zijn, is PAS vooral interessant omdat die twee afkappunten geeft waarbij een echografie en/of een CT-scan vermeden kan worden of, zoals in de huisartspraktijk het geval kan zijn, wanneer technische onderzoeken niet onmiddellijk aangewend kunnen worden. Enerzijds wordt aangegeven dat een patiënt met een lage score op dat moment niet verder onderzocht hoeft te worden en anderzijds dat patiënten met een hogere score onmiddellijk een laparoscopie kunnen ondergaan. Weliswaar is er de beperking van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het klinisch onderzoek (kappa = 0,66 bij Alvarado en 0,59 bij PAS) (4). Hierbij wijst de literatuur op het belang van herevaluatie en dit het liefst door dezelfde arts ingeval de twijfel blijft bestaan.

De PAS-score leert ons ook om als huisarts beter om te gaan met de soms moeilijke diagnostiek van appendicitis en hierbij een aantal overtollige CT-scans te vermijden bij het vermoeden ervan, vooral bij kinderen. We dachten dat dit een nuttige aanvulling kon zijn bij het mooie overzicht van Kwanten W.J., et al.

J. Matthys

Huisarts

Vakgroep Huisartsgeneeskunde UG

Literatuur

1. KWANTEN WJ, PELCKMANS PA, VANEERDEWEG W, DENEKENS J, MOREELS TG. Diagnostische aanpak bij patiënten met vermoeden op acute appendicitis. Tijdschr Geneesk 2011; 67: 1045-1050.
2. BHATT M, JOSEPH L, DUCHARME FM, DOUGHERTY G, MCGILLIVRAY D. Prospective validation of the pediatric appendicitis score in a Canadian pediatric emergency department. Acad Emerg Med 2009; 16: 591-596.
3. VAN WINCKEL M, et al. Reeks avondcolloquia voor de practicus. Pediatrische pathologie tijdens de wacht d.d. 6 oktober 2010.
4. MANDEVILLE K, POTTKER T, BULLOCH B, LIU J. Using appendicitis scores in the pediatric ED. Am J Emerg Med 2011; 29: 972-977.